

张建来 mPDAC MDT 病史汇报 v1.2 (2026-07-22)

张建来 晚期胰腺导管腺癌 MDT 病史汇报 (v1.2)

汇报日期：2026-07-22 (v1.2 更新版) **版本说明：**v1.0 = 2026-07-15; v1.1 = 2026-07-16; **v1.2 = 2026-07-22**, 在 v1.1 基础上增补 7/19-7/21 的关键化验、7/20 北医三院就诊、Grade 3 胃衰竭确诊、二线方案更新 (GFH375 Ph3 路径、nal-IRI 兜底、Zolbetuximab 项目终止、CT041 硬性排除)、帕金森综合征 (血管性) 诊断精修、蒋斌 7/14 二线咨询、美中爱瑞尽调、以及居家咨询/网购胃动力药评估等结论。 **汇报目的：**提交多学科会诊 (MDT)，聚焦 **Grade 3 胃衰竭营养通道重建 + 胆道塑料支架 Plan B (EUS-HGS) + 二线治疗方向 (GFH375 Ph3 / nal-IRI)**

一、患者基本信息

项目	内容
姓名	张建来
性别	男
出生日期	1958-05-04 (68 岁)
身份证号	340504195805040039
民族	汉族
籍贯	安徽省 (久居北京)
职业	退休 (原北京瑞尔非金属材料有限公司)
紧急联系人	张成毅 (子), 18600058581
当前住院	北京中关村医院 肿瘤病区 (住院号 106034, 床号 05-09, 2026-06-23 起)
主要照护家属	儿子 (robinzhangcy@gmail.com)

二、主诊断与分期

主诊断：胰腺中低分化导管腺癌 (PDAC)，胰头钩突占位，IV 期 (cT3N1M1，肝多发转移)

病理确诊：2026-04-07 EUS-FNA 穿刺活检 (北医三院) **首发症状时间：**2026 年 3 月中下旬皮肤巩膜黄染

分期依据：2026-06-14 中国医学科学院肿瘤医院上腹 MR 动态增强+DWI 明确肝多发转移瘤 **可切除性：**不可手术 (SMV 受压+可疑 SMA 侵犯+肝多发转移)

【v1.2 新增】当前活动性问题清单（按紧迫度）

- 1. ☒ **Grade 3 胃衰竭（Gastric Failure）**（2026-07-20 确诊）— 液体都无法通过胃排空，经口进食通道基本关闭；SEMS 通畅但 15-25% 患者存在"patent but non-functional"（Havemann 2009 PMID:19468999）；ACG 2022 Rec 24 EN/PN 绝对适应证
- 2. ☒ **胆道塑料支架亚急性堵塞/生物膜性感染**（2026-07-12 起）— 8 条证据链聚焦；塑料支架已在位 3 个月；**2026-07-20 北医三院评估无法经内镜更换**，需 Plan B（EUS-HGS 首选 / PTCD 兜底）
- 3. ☐ **恶病质早期**（cachexia）— CK 14 ↓ + Mb <21 ↓ + Cr 46 ↓ + ALB 33.9 ↓ 双-三重证据
- 4. ☐ **慢性高凝活跃期**（不 DIC）— D-Dimer 0.957 ↑（vs 7/3 +105%）+ FDP 7.87 ↑ + PT-% 74 ↓（VitK 吸收障碍）
- 5. ☐ **电解质紊乱**（Na 132 ↓ 加重、K 3.56 临界下限）
- 6. ☐ **AG 化疗后疗效评估暂停**：C3 完成（6/8 D1），C4 因胆管炎+胃衰竭+营养危机推迟；下一步方案（C4 继续 / 减量 / 换 nal-IRI / 入试验）待 MDT
- 7. ☒ **心功能安全**（NT-proBNP 100.2 + TnT 0.008，2026-07-19 首次基线）— 为强化抗凝/手术/二线化疗提供安全档
- 8. ☒ **PLT 反弹**（7/12 111 → 7/19 177，+59%）— 换支架手术+LMWH 抗凝血液学准备就绪

三、既往史与合并症

3.1 既往合并症（2026-04-03 北医三院入院志记载）

慢病	病史	长期用药
高血压病 3 级	20 余年（最高 180 mmHg）	缬沙坦 80 mg QD + 氨氯地平 5 mg QD
高血压性脑出血	8 年（2018 年），保守治疗后好转	—
陈旧性脑梗死	3 年（2023 年），遗留双下肢无力	—
帕金森综合征（v1.2 精修：血管性帕金森综合征 VP 高度可能）	数年	雷沙吉兰 1 mg QD + 金刚烷胺 0.1 g BID + 甲钴胺 0.5 mg QD + 多巴丝肼 0.125 g-0.5 g-0.5 g TID
高脂血症	数年	阿托伐他汀 20 mg QN
脑卒中二级预防	—	西洛他唑 50 mg BID（抗血小板）
桥本氏甲状腺炎（2026-06-25 新发现）	—	抗体阳性（TGAb 312 ↑、TPOAb 72.2 ↑），甲功五项待完善

☒ 【v1.2 关键澄清】"帕金森"诊断精修（对胃动力药选择直接相关）：

- **诊断更正**：爸爸是**帕金森综合征（Parkinsonism）**，最可能病因**血管性帕金森综合征（Vascular Parkinsonism, VP）**，而非原发帕金森病（PD）
- **依据**：高血压 20+ 年 + 高血压性脑出血（2018）+ 陈旧性脑梗死（2023）+ 颈动脉双侧粥样斑块（2026-04-04）
- **用药印证**：雷沙吉兰+金刚烷胺+甲钴胺+多巴丝肼 = 继发性帕金森综合征典型治疗

- **对胃动力药禁忌的影响（重要）：**

- 甲氧氯普胺（胃复安）继续**绝对禁用**（FDA 黑框；ACG 2022 Rec 12）
 - **多潘立酮需更严格监测**：既往脑出血+脑梗 → 血脑屏障可能受损 → 中枢渗透风险↑；需 **ECG QTc<450 ms** + ≤30 mg/d + ≤7 天 + 密切观察运动症状
 - **建议先用红霉素 3-5 天，再决定是否加多潘立酮**
 - 建议神经内科会诊评估帕金森综合征稳定性
- **文献**：Zijlmans 2004 *Mov Disord* (VP 诊断标准)；Vale 2020 *Front Neurol*；Barone 2011 *Mov Disord* (MDS 帕金森综合征胃肠管理)；Rao & Camilleri 2010 *APT*

3.2 既往手术史

- **本次胰腺癌之前无任何大手术史**（2026-06-28 家属复核）
- 本次相关手术：
 - 2026-04-07 EUS-FNA 胰腺穿刺活检（北医三院）
 - 2026-04-10 ERCP + DSA 胆道**塑料**支架置入术（北医三院）
 - 2026-06-22 内镜下经鼻三腔营养管置入术（北医三院普外急诊，因胃潴留+十二指肠恶性狭窄）
 - **2026-07-02 十二指肠 SEMS 金属自膨胀支架置入术（北医三院；同期撤除三腔营养管，恢复口服）**

3.3 过敏史

无药物、食物、造影剂过敏史（2026-06-28 家属复核）

3.4 个人史

- 生于安徽，久居北京
- **不吸烟、不饮酒**（入院志与家属双重确认）
- 无疫区/疫水、无化学放射性接触史、无吸毒史

3.5 家族史

否认家族性遗传病史与肿瘤家族史。 综合"不吸烟+不饮酒+无家族肿瘤史"及基因检测（KRAS G12D + CDKN2A + Smad4 缺失）→ 提示**散发性体细胞驱动突变型 PDAC**，非遗传性。

四、诊疗时间线（关键节点）

日期	医院	关键事件
2026-03 中旬	—	出现皮肤巩膜黄染（首发症状）
2026-03-30	北京协和急诊	基线全套：CA19-9 2203 、TBIL 162.3、ALT 214、CRP 23.76、AMY 184；胸部 CT 示胆总管下段团块
2026-04-01	北京协和（国际医疗肝胆外科）	首诊：胰腺恶性肿瘤 + 梗阻性黄疸
2026-04-02	北京协和（特需基本外科）	制定"新辅助化疗 + 胆道引流"方案
2026-04-03	北医三院普外二病房（住院号 5047176）	入院；MRCP：胰头肿块 45 mm，双管征
2026-04-04	北医三院	腹盆腔 CT 增强：胰头 45 mm，与门静脉关系密切；消化系统彩超：胰头钩突 7.1×4.1×3.6 cm 、SMV 受压、CBD 2.3 cm 极度扩张、肝囊肿 1.5 cm、胆囊息肉 0.3 cm、 肝脏未见转移瘤 ；双下肢静脉： 无血栓（VTE 基线） ；颈动脉：双侧粥样斑块（0-49% 轻度狭窄）
2026-04-07	北医三院	EUS-FNA 穿刺活检 → 病理： 胰腺中低分化腺癌 ；超声造影示典型 PDAC 乏血供表现
2026-04-10	北医三院	ERCP + DSA 胆道塑料支架置入术 （张铃福医生）
2026-04-14	北医三院	出院；出院带药：耐信 20 mg BID + 易善复 456 mg TID + 天晴甘平 150 mg TID + 迪先 10 ml BID
2026-04-16 / 04-22	北医三院	病理免疫组化补充：MMR pMMR、HER2 1+、PD-L1 CPS<1、Smad4 缺失
2026-04-27	北医三院	NGS 报告： KRAS G12D、TP53 V274D、CDKN2A 缺失、ARID1A、MTAP 缺失、Claudin18.2 3+ 60%
2026-05-09	中国医学科学院肿瘤医院	化疗前真正基线 CT 增强（胸+全腹+盆腔+薄层） ：胰头 4.2×3.8 cm，侵犯十二指肠降+水平段、SMV、可疑 SMA； 肝多发转移瘤可能（最大 1.2×1.1 cm） ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔少量积液+腹膜稍厚；双肺结节 0.8×0.5 cm；双肾囊肿 → 实际确诊即 IV 期 mPDAC （05-12 出院时报告为 T3N0M0 II 期系初步低估）
2026-05-11	中国医学科学院肿瘤医院	C1D1 AG 化疗 ：白蛋白紫杉醇 190 mg + 吉西他滨 1.6 g
2026-05-13	清华长庚	苏日嘎教授（肝胆肿瘤科）咨询意见
2026-05-25	中国医学科学院肿瘤医院	C2D1（方案改为 14 天周期）

日期	医院	关键事件
2026-06-08	中国医学科学院肿瘤医院	C3D1
2026-06-13	中国医学科学院肿瘤医院	CT 增强疗效评估：胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm → AG 有效
2026-06-14	中国医学科学院肿瘤医院	上腹 MR 动态增强+DWI：明确肝多发转移瘤（1.2×1.0 cm）→ 分期 II 上调 IV（mPDAC）
2026-06-18	中国医学科学院肿瘤医院 C3D10	☑ 化验补录发现"胆管炎 3 天前驱期"完整证据链：血常规 24 项（MONO% 11.2↑ 唯一非贫血异常，EO# 0.05 临界低）+ 生化 19 项（ALP 140.9↑ 1.13×、DBIL 4.9↑ 1.23× 双升胆道支架亚临床炎症；ALT 33.8 ☑、AST 26.7 ☑、TBIL 14.5 ☑ 全正常）+ 肿瘤标志物 5 项（CA19-9 402 / CA242 77.6，均较 5/9 上升，含胆道支架炎症干扰）+ 凝血 10 项（D-Dimer 1.27↑ 首次高凝证据，FDP 3.54 ☑ AT-III 94.1 ☑）
2026-06-21	急诊	☑ 反酸呕吐 24 h + 发热 39.2 °C + WBC 13.15/NEUT% 91.1%/CRP 69 + ALT 632/AST 520/ALP 540/GGT 608/TBIL 39.7 → 急性胆管炎 Grade II（胆道塑料支架相关）+ 恶性十二指肠梗阻
2026-06-22	北医三院	美罗培南 15 h 有效（PCT 2.91→1.88，AST 520→238）； 内镜下经鼻三腔营养管置入 （诊断：十二指肠降部恶性狭窄，建议必要时行 SEMS 或 EUS-GE）
2026-06-23	中关村医院肿瘤病区	转入住院 ；启动双轨营养 TPF 60 ml/h 鼻饲 + PN 约 650 kcal/d；抗生素降阶梯为头孢他啶+美洛西林+左奥硝唑三联；保肝（谷胱甘肽+硫普罗宁）； 肿瘤标志物复查：CA19-9 362、CA242 37.2 （-52% vs 6/18，☑CA19-9/CA242 解偶联）； 中关村凝血 10 项 ：D-Dimer 1.091↑、FDP 8.11↑、FIB 425↑、AT:A 80↓ → 完整高凝四联登场 （vs 6/18 仅单项高凝）
2026-06-23	中国医学科学院肿瘤医院	胰胃外科王敏主任门诊
2026-06-25	中关村医院肿瘤病区	甲状腺自身抗体：TGAb 312↑ + TPOAb 72.2↑ → 桥本氏甲状腺炎 （新发现）；PCT 0.767；IL-6 23；呼吸道病原体 5 项 IgM 全阴
2026-07-02	北医三院	十二指肠 SEMS 置入术 （BOSTON 6502 WallFlex 27/22×9 + Jagwire 导丝，医保 23,199 元）；同日上午北京大学肿瘤医院周军主任二线咨询门诊； 当天中关村凝血 10 项 ：D-Dimer 0.468（-57% vs 6/23）、FDP 3.64（-55%）、FIB 357 ☑ → 高凝四联 3/4 项 9 天内回落，仅 AT:A 76 继续降 → 感染源控制 = 最有效抗凝措施
2026-07-03	中关村医院肿瘤病区	血液学全面恢复：WBC 5.42/NEUT 3.79/PLT 272/HGB 90↑； PCT 0.135 ☑ 感染最低点 ；IL-6 11.63；肝功能爆炸性恢复： ALT 25.5（-96%）、AST 23.4（-96%）、TBIL 7.8（-80%）全正常 ；仅 GGT 227.7↑
2026-07-09 至 07-11	中关村医院肿瘤病区	☑ 连续 3 天发烧 （胆道感染再激活提示）
2026-07-12	中关村医院肿瘤病区	☑ 全套化验三系反弹 （血常规 24 项 + 生化 19 项 + 免疫 2 项）： ALT 74.4↑、GGT 262.1↑↑、PCT 0.522↑、IL-6 16.97↑、PLT 111↓、ALB 32.8↓、Cr 46↓、Na 133.6↓ ；关键正常： TBIL 7.3 ☑、AMY 21.7 ☑ （排除 SEMS 术后急性胰腺炎）
2026-07-14	北京美中爱瑞肿瘤医院	蒋斌副主任医师门诊（肝胆肿瘤中心）— 二线方案咨询 （触发：美中爱瑞加入 Mayo Clinic Care Network 梅奥联盟） 蒋斌意见 ☑ ：① 不需要美国专家（当前处于营养支持

日期	医院	关键事件
		阶段，非治疗决策窗口) ② 有条件应争取临床试验入组 —— 与 7/2 周军主任、田爱茹主管方向完全一致（三家医院独立医生高置信度共识）
2026-07-19	中关村医院肿瘤病区	☑ 三份化验大转折（生化 24 项 + 免疫 5 项 + 血常规 24 项 + 凝血 10 项，肿瘤内科霍菲菲开单，21:50 送检）— 详见第七节。核心：ALT 21.4 ☑ (-71%) + AST 21.9 ☑ + TBIL 6.6 ☑ + LD 155 ☑ 肝功能完全恢复，7/12 反弹为一过性；PLT 177 ☑ (+59%) + WBC 5.72/NEUT 4.28 全正常 手术血液学准备就绪；NT-proBNP 100.2 ☑ + TnT 0.008 ☑ 心功能安全底座；D-Dimer 0.957 ↑↑ (+105%) + PT-% 74 ↓ (首次) + FDP 7.87 ↑ VitK 吸收障碍+新发微血栓活跃；PCT 0.700 ↑↑ (vs 7/3 +419%) 生物膜性感染证据加强；Mb <21 ↓ + CK 14 ↓ + Cr 45 ↓ + ALB 33.9 ↓ + Na 132.0 ↓ 恶病质加深+电解质紊乱
2026-07-19 下午	家	呕吐 1 次（食物残渣，无发热无血，有排气排便）
2026-07-20 上午	家	呕吐 1 次（两口食物残渣，无发热）；家人补充"水都下不去" → 修正为 重度胃排空障碍/Grade 3 胃衰竭
2026-07-20 下午	北医三院	△ 胆道塑料支架无法经内镜更换（具体原因待补：SEMS 阻挡 ERCP 入路 / 病情限制）；☑ SEMS 十二指肠支架通畅（造影剂顺利通过）；☑ 胃内大量积水（胃减压抽出）；☑ 抽水后无腹胀（症状可逆，非胃壁弹性问题）→ 确诊 Grade 3 胃衰竭（ACG 2022 Camilleri）+ 胆道支架 Plan B 必需
2026-07-21 上午	家	呕吐 1 次（300 ml 水 + 少量小米粥；呕吐物潜血阴性 ☑）→ 液体+少量流食均无法耐受，SEMS 通畅 → 功能性胃瘫定性诊断确立，NJ 管紧迫度上升到"不能再拖"
2026-07-22（本汇报日）	—	生成 v1.2 汇报；C4 化疗待 MDT 决策

五、关键影像学总结

检查	日期	医院	关键发现
胸部 CT 平扫	2026-03-30	协和急诊	胆总管下段团块，双肺微小结节
MRCP	2026-04-03	北医三院	胰头肿块 45 mm，双管征
腹盆腔 CT 增强	2026-04-04	北医三院	胰头 45 mm，与门静脉关系密切
消化系统彩超	2026-04-04	北医三院	胰头钩突 7.1×4.1×3.6 cm + SMV 受压 + CBD 2.3 cm 扩张 + 肝脏未见转移
超声造影（穿刺同期）	2026-04-07	北医三院	典型 PDAC 乏血供廓清早于胰腺组织
化疗前基线 CT 增强+薄层	2026-05-09	中国医学科学院肿瘤医院	胰头 4.2×3.8 cm；侵犯十二指肠降+水平段 + SMV + 可疑 SMA； 肝多发转移瘤可能 (1.2×1.1 cm) ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔积液；双肺结节；双肾囊肿
AG 疗效评估 CT 增强	2026-06-13	中国医学科学院肿瘤医院	胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm； AG 有效
上腹 MR 动态增强+DWI	2026-06-14	中国医学科学院肿瘤医院	胰头 4.9×3.8 cm；肝多发 DWI 高信号结节 1.2×1.0 cm → 明确诊断"肝多发转移瘤"（分期升至 IV）

六、分子病理与基因检测（NGS 2026-04-27）

检测	结果	临床意义
KRAS	G12D (c.35G>A, VAF 26.94%)	驱动突变；G12D 特异性抑制剂在研（HRS-4642 / Zoldonrasib / GFH375 / INCB161734）
TP53	V274D (c.821T>A, 37.12%)	抑癌基因失活；WEE1 抑制剂潜在靶点
CDKN2A	拷贝数缺失（CN=1.16）	细胞周期失调
ARID1A	D2178Gfs*47 (24.19%)	功能丧失
MTAP	杂合缺失（9p21.3）	MAT2A 抑制剂靶点（在研）
RNF43	A46S	Wnt 通路，意义不明
BIRC3	BIRC3-METTL25B 融合（15.43%）	意义不明
MSI	MSS	免疫单药无效
TMB	4.1 突变/Mb（低）	免疫单药无效
PD-L1	阴性（CPS<1, SP263）	免疫单药无效
Smad4/DPC4	表达缺失	预后不良，倾向远处转移；提示吉西他滨方案更适合
HER2	1+（低表达）	传统 HER2 靶向药不适；T-DXd 潜在二线备选
MMR	pMMR（四项正常）	与 MSS 一致
Claudin 18.2	阳性（60%，3+）	符合 CLDN18.2 靶向治疗标准（Zolbetuximab、CLDN18.2 ADC、CT041 CAR-T）
BRCA1/2	无突变	PARP 抑制剂不适

核心可干预靶点：
KRAS G12D（一级）+ Claudin 18.2 3+ 60%（一级）+ TP53/CDKN2A/MTAP（研究级）

七、关键指标趋势

7.1 CA19-9 与 CA242（肿瘤标志物解偶联 ☒）

日期	CA19-9	CA242	说明
2026-03-30	2203 ☒	125.8 ☒	基线（重度黄疸）
2026-05-09	255	52.9	↓ 88% / ↓ 58%（主因 ERCP 引流）
2026-06-18	402 ↑	77.6 ↑	C3D10：CA19-9 +58% / CA242 +47%（含胆道支架亚临床炎症干扰）
2026-06-23	362 ↑	37.2 ☒	胆管炎爆发 D2；☒ CA242 从 6/18 骤降 52%，vs 5/9 净降 30% ☒

7.2 TBIL（总胆红素）

2026-03-30: 162.3 → 05-09: 53.8（-67%）→ 05-19: 29.9（-82%）→ 07-03: 7.8 ☒ → 07-12: 7.3 ☒（仍正常）

关键：7/12 ALT/GGT 反弹但 TBIL 未升 → 胆道支架未完全堵塞，处于早期干预窗

7.3 化疗骨髓抑制轨迹

时点	WBC	NEUT	HGB	PLT	备注
5/9 化疗前	5.06	—	100	215	基线
5/16 C1D5	3.42 ↓	2.01	96	216	
5/28 C1D17	3.54	2.21	82 ↓ ↓	333	
5/31 C2D6	2.63 ↓ ↓	1.18 ↓ ↓	85	321	II 度粒减 + WBC 减
6/3 C2D9	3.68	1.82	81	225	
6/18 C3D10	3.96 ☒	2.12 ☒	97 ↑	220 ☒	☒ 胆管炎前基线：骨髓已充分恢复（HGB 回升 20%）
7/3 C3D25 （SEMS 后 D1）	5.42 ☒	3.79 ☒	90	272	全面恢复
7/12 C3D34	5.53 ☒	4.06 ☒	87 ↓	111 ↓ ↓	☒ PLT 大幅下降（消耗型，非骨髓抑制型）
7/19 C3D41	5.72 ☒	4.28 ☒	92 ↑	177 ☒	☒☒☒ PLT 反弹 +59%（消耗性血小板减少逆转），骨髓产板功能完全恢复；LYM# 0.89 ↓（AG 后淋巴抑制持续）；MPV 10.1/PDW 11.3 形态学正常

7.4 感染监测轨迹 (PCT / IL-6)

日期	PCT	IL-6	事件
6/21	2.91 ☒☒☒	—	☒ 急性胆管炎爆发
6/22	1.88	—	美罗培南 15 h -35%
6/25 (=6/24 采样)	0.767	23	抗生素降阶梯
7/3	0.135 ☒	11.63	最低点
7/9	0.396 ↑	23.64 ↑	SEMS 术后 D7 早期反弹
7/12	0.522 ↑↑	16.97 ↑	△ 反弹 4 倍，胆道感染再激活
7/19	☒ 0.700 ↑↑ (+34% vs 7/12; +419% vs 7/3)	10.17 ↑ (-40% vs 7/12)	☒ PCT 与 IL-6 解偶联：舒普深压得住"炎症风暴" (IL-6↓) 压不住"细菌载量" (PCT↑) → 生物膜性感染典型表现 → 机械清除 (换支架) 比继续抗生素更关键

7.5 【新增】高凝状态三阶段演变 (凝血四联)

时点	D-Dimer	FDP	FIB	AT:A	阶段	备注
4/4 基线	—	—	—	—	干净	双下肢静脉超声无血栓
6/18 (C3D10)	1.27 ↑	3.54 ☒	369	94.1 ☒	Phase 1: 慢性高凝	☒ 仅 D-Dimer 孤立升高 (CAT 模式：肿瘤+化疗+卧床+多导管)，无炎症干扰
6/23 (胆管炎 D2)	1.091 ↑	8.11 ↑	425 ↑	80 ↓	Phase 2: 完整高凝四联	☒ FDP +129% 爆发 + AT:A 消耗启动；PT/APTT 仍正常 (未 DIC)
7/2 (SEMS 术后)	0.468 ↑	3.64 ☒	357 ☒	76 ↓	Phase 3: 消退期	☒ FDP -55%、FIB -16%、D-Dimer -57% 三项回落；唯 AT:A 继续降 (抗凝储备恢复滞后)
7/3	0.468	—	—	—	稳定	无新发 DVT/PE
7/19 (再度攀升)	☒ 0.957 ↑↑ (+105% vs 7/3; 3.94×上限)	7.87 ↑ (vs 6/23 -3%)	361 ☒ (回落)	85 ☒	Phase 4: 新发微血栓活跃期	☒ D-Dimer/FDP 解偶联 (+105% vs -3%) → 新形成纤维蛋白凝块+降解为主，非陈旧血栓崩解 → 新发或活动性微血栓形成 (内脏/腹腔血管高凝可能)；APTT 30.5/TT 15.8/INR 1.19 全正常 → 仍未 DIC；AT:A 从 76→85 反而回升

7.6 【v1.2 新增】凝血合成障碍（VitK 吸收依赖因子）

日期	PT 活动度	备注
7/19	74% ↓（首次记录降低，参考 80-120%）	☑ PT/INR 仍正常（PT 13.3 sec/INR 1.19），但活动度降至 80% 以下

机制：胆汁淤积（GGT 262 ↑）+ 长期 PN 无经口 VitK 摄入 → 维生素 K 依赖性因子（II/VII/IX/X）活性下降
临床意义：单独 PT-% 74% 不至于出血高危；但与 **D-Dimer 0.957 ↑ + PLT 111（7/12）→ 177（7/19）**
组合提示凝血系统正在双向失衡（既高凝又合成不足）**典型链条：**胆道支架堵塞 → 胆汁不入肠 → 脂溶性 VitK 吸收障碍 **处置：****VitK1 10 mg IM/IV**（起效 12-24h，经典胆汁淤积补法）

7.7 【v1.2 新增】心功能安全底座（2026-07-19 首次记录）

指标	结果	参考	判断
NT-proBNP	100.2 pg/mL	≤300	☑ 无心力衰竭
TnT 肌钙蛋白 T	0.008 ng/mL	0-0.100	☑ 无心肌损伤
LD 乳酸脱氢酶	155 U/L	135-225	☑ 组织损伤/肿瘤活动标志消除（vs 6/21 572 -73%）
CK-MB	11.1 U/L	0-25	☑ 心肌无损伤

➔ **心脏功能安全档：**为强化抗凝（LMWH）/换支架手术/二线化疗方案决策提供底座。

7.8 【v1.2 新增】恶病质双-三重证据链（2026-07-19）

指标	结果	参考	判断
CK 肌酸激酶	14 ↓	34-170	☑ 骨骼肌流失客观证据
Mb 肌红蛋白	<21 ↓	28-72	☑ 骨骼肌流失第二证据
Cr 肌酐	45 ↓	59-104	⚠ 肌肉量减少（非肾功能问题，eGFR 111 ☑ 优秀）
ALB 白蛋白	33.9 ↓	35-55	⚠ 低白蛋白（vs 7/12 32.8 略回升）
A/G 白球比	1.2	1.5-2.5	⚠ 偏低（慢性消耗）
Urea 尿素	3.64	3.60-9.50	⚠ 刚过下限（蛋白摄入偏少）

核心机制：Grade 3 胃衰竭 + 长期 PN 无经口 + 化疗后异化状态 → **恶病质活动期（cachexia active phase）** **目标（ESPEN 2021 Muscaritoli PMID: 33745726）：**25-30 kcal/kg/d × 65 kg = **1600-1950 kcal/d**；蛋白 1.2-1.5 g/kg/d = **78-98 g** **营养通道决策：**见第九节 A

7.9 【v1.2 新增】电解质紊乱

指标	7/12	7/19	参考	变化
Na	133.6 ↓	132.0 ↓	135-145	继续下降 -1.6，轻度低钠加重
K	—	3.56 △	3.50-5.30	临界下限（刚过 0.06）
Cl	—	102.0 ☒	96-108	正常
TCO2	—	24 ☒	22-29	酸碱平衡良好

临床意义：Na 132 + K 3.56 组合**完全可以解释 7/19-7/21 反复呕吐+恶心+打嗝**（除胃瘫机制外的可纠正因素）。需补钠+预防性补钾+鉴别 SIADH。

八、既往就诊/咨询医生一览

八、既往就诊/咨询医生一览

医院	科室 / 医生	事件
北京协和医院	国际医疗肝胆外科（戴梦华） / 特需基本外科（刘乔飞）	2026-04-01/02 首诊 + 制定新辅助化疗+胆道引流方案
北京大学第三医院	普外二病房（马新晖/伍佳龙签字）	2026-04-03 入院志
北京大学第三医院	普外科主任医师 张铃福 ☑	2026-04-10 ERCP+DSA 胆道塑料支架置入
北京大学第三医院	普外急诊 消化内科 姚炜/张耀朋 ☑	2026-06-22 内镜下经鼻三腔营养管置入
北京大学第三医院	内镜中心 消化内科 姚炜 ☑	2026-07-02 十二指肠 SEMS 置入（同期撤除三腔管，营养全改口服）
北京大学第三医院	内镜中心 消化内科 姚炜 ☑	2026-07-20 评估胆道塑料支架 → 无法经内镜更换 + SEMS 通畅确认 + 胃内大量积水抽出
中国医学科学院肿瘤医院	内科 廊坊院区 田爱茹 ☑（主管）	AG 化疗主管（C1 2026-05-11 / C2 2026-05-25 / C3 2026-06-08）
中国医学科学院肿瘤医院	胰胃外科 王敏	2026-04-07 / 2026-06-23 门诊
北京朝阳医院	肝胆胰腺外科 樊华	2026-04-24 第二意见
北京清华长庚医院	肝胆肿瘤科 苏日嘎	2026-05-13 挂号咨询（张琳号已退未就诊）
北京大学肿瘤医院	主任医师 周军	2026-07-02 二线咨询门诊
北京美中爱瑞肿瘤医院	肝胆肿瘤中心 副主任医师 蒋斌（个案管理师 17610762897）	2026-04-30 初诊咨询 + 2026-07-14 二线方案咨询（结论：不需美国专家，有条件应争取临床试验入组）
北京中关村医院	肿瘤病区 霍菲菲（当前主治）	2026-06-23 起住院至今（住院号 106034，床号 05-09）

☑ 三家医院独立医生方向一致（高置信度决策锚点）：田爱茹（主管）+ 周军（北大肿瘤二线）+ 蒋斌（美中爱瑞肝胆）均指向"稳定病情后争取临床试验入组"。

九、【v1.2 新增】当前核心临床决策问题（MDT 讨论重点）

9.A Grade 3 胃衰竭 —— 营养通道重建（最紧迫）

诊断依据（ACG 2022 Gastroparesis Guideline, Camilleri et al. *Am J Gastroenterol* 2022, DOI: 10.14309/ajg.0000000000001874; 沿用 Abell/ANMS 2006 三级分级 PMID: 16553582):

- Grade 3 定义：药物难治 + 不能维持水化和营养 + 需 EN/PN 支持
- **爸爸"液体都不下去" = Grade 3 硬指标**（2026-07-20 家人确认，7/21 300 ml 水 + 少量小米粥呕吐再次印证）
- GCSI 评分预计 ≥ 4.0 （Revicki 2003 PMID: 12848636，阈值 3.0）
- **ACG 2022 Rec 24 (Conditional)**：Grade 3 是 EN/PN **绝对适应证**

SEMS 通畅但胃瘫的机制（Havemann 2009 PMID: 19468999）：

- 十二指肠 SEMS 技术成功率 95% 但临床成功率仅 80-85%
- **15-25% 患者"patent but non-functional"**
- 病程 >4 周 GOO 患者中 40% 有"gastric atony"

爸爸病理机制（混合型）：神经病成分 60-70%（帕金森综合征 α -syn + PDAC 腹腔神经丛 + AG 化疗神经毒性）+ 肌病成分 30-40%（SEMS 前长期 GOO 扩张 $\rightarrow$ atonic dilation）

营养通道决策 —— NJ 管（鼻空肠管）首选：

- ESPEN 2021 Rec 5（Grade B，100% 共识）：EN 优先于 PN
- ESPEN 2021 Rec 32（Grade B）：EN <60% 目标 >7-10 天 $\rightarrow$ 加补充 PN
- SEMS 内穿越 NJ 管成功率 85-95%（Nagaraja 2014 *GIE*；Song 2007 *Radiology*）
- 操作要点：8-10 Fr 细径 + 超细内镜(<6 mm) + Treitz 韧带远端 20-30 cm
- **推荐团队**：北医三院姚炜（做过 6/22 三腔管，技术熟悉；7/20 已参与本次评估）
- **PEJ 不推荐**：恶病质造瘘愈合差 + PDAC 腹膜种植风险 + 预期生存 3-6 月

药物治疗（ACG 2022 Rec 12-15 + MDS Barone 2011）：

优先	药物	剂量	备注
☒ 首选（急救）	红霉素 IV	3 mg/kg q8h $\times$ 3-7 天	2-4 周耐受；与阿托伐他汀/西洛他唑相互作用需评估
☒ 次选	多潘立酮	10 mg tid $\leq$ 7 天	需 ECG QTc<450 ms（血管性帕金森更严格）
☒ 备选	莫沙必利	5 mg tid	温和长期；5-HT ₄ 激动剂，不影响 D ₂ 通路，帕金森安全
☒ 进阶	普芦卡必利	2 mg qd	Carbone 2019 <i>AJG</i>
☒ 禁忌	甲氧氯普胺（胃复安）	—	FDA 黑框，帕金森综合征绝对禁用
☒ 不推荐	伊托必利（为力苏）	—	含 D ₂ 拮抗成分（Talley 2003 <i>APT</i> ），VP 血脑屏障受损 $\rightarrow$ 中枢渗透风险

营养目标 (ESPEN 2021 Muscaritoli PMID: 33745726):

- 热卡 25-30 kcal/kg/d $\times$ 65 kg = **1600-1950 kcal/d**
- 蛋白 1.2-1.5 g/kg/d = **78-98 g/d**
- BCAA + ω -3 脂肪乳强化 + 白蛋白输注 (ALB 33.9 $\downarrow$)

9.B 胆道塑料支架 Plan B (EUS-HGS 首选, PTCD 兜底)

依据:

- ESGE 2022 (Ogura et al.) — EUS-BD 推荐指南
- WEO 2019 (Isayama et al.) — 国际共识
- Sharaiha Meta 2017 PMID: 27889387 — EUS-BD vs PTCD

数据:

- EUS-BD 不良事件 17% vs PTCD 32% ($P < 0.01$)
- 30 天再干预率 EUS-BD 14% vs PTCD 55% ($P < 0.001$)
- **SEMS 在位患者首选 EUS-HGS (肝管-胃吻合)** ——经胃壁绕过 SEMS 进入左肝内胆管
- 技术成功率 89-93%, 临床成功率 85-90%, 通畅期约 6 个月

北京推荐团队:

1. ☒ ☒ ☒ 令狐恩强 / 王向东 (解放军总医院 301) — 全国最强 EUS-BD
2. ☒ ☒ 张澍田 / 李鹏 (北京友谊医院)
3. ☒ ☒ 邹英华 / 朱旭 (北大肿瘤医院 PTCD 兜底)

当前手术条件 (血液学准备就绪):

- ☒ PLT 177 ($\geq$ 50-100 手术阈值)
- ☒ WBC 5.72 / NEUT 4.28 (抗感染武器充足)
- ☒ 心功能 NT-proBNP 100.2 + TnT 0.008
- $\triangle$ PT-% 74 $\downarrow$ $\rightarrow$ **术前 VitK1 10 mg IM/IV 补充** (12-24 h 起效)
- ☒ PCT 0.700 $\uparrow \uparrow$ (生物膜性感染, 抗生素边际递减 $\rightarrow$ 机械清除是唯一根本解)

9.C 【v1.2 大幅更新】二线治疗方向

$\triangle$ 昨版 (v1.1) 关于二线方向的部分结论已修正:

修正 1: CT041 CLDN18.2 CAR-T —— 由"主线值得实操"降级为"硬性排除"

- Claudin 18.2 60% 3+ 分子完美命中 (Qi C et al. JCO 2024 PMID: 38788174; ORR 16.7%, DCR 70.8%, mOS 10.0 m)
- **但爸爸当前 ECOG 2-3 + 亚急性胆管炎 + Grade 3 胃衰竭 $\rightarrow$ 硬性排除**
- NCT03874897 已完成 / NCT04581473 已停招 / **NCT05539677 关键 Ph2 要求 ECOG 0-1**
- CAR-T 预处理化疗致 7-14 天粒缺 + 亚急性胆管炎背景 = 高风险

- v1.1 "稳定 4-6 周后入 CT041" 结论不准确：即使 ECOG 恢复至 1，主流 CT041 试验入组窗口对 M1 大量肝转移+SEMS 在位病例已趋闭
- ⚠ 若任何机构（含美中爱瑞）推销"细胞治疗 30-100 万自费方案" → 直接拒绝，索取 NCT/ChiCTR 号

修正 2: Zolbetuximab（佐妥昔单抗）—— 由"潜在选项"改为"PDAC 项目已终止"

- NCT03816163 一线 PDAC Ph3 终期分析阴性（2025-10）
- Astellas 2025-12 官宣**终止胰腺癌开发**
- Off-label 使用 30-50 万/年自费，**无循证意义**
- 胃癌适应证仍在，但对本例 PDAC 已不适用

☒ 新增 1: GFH375（劲方医药 KRAS G12D 特异性小分子）—— 首选咨询

- **分子命中**：爸爸 KRAS G12D VAF 26.94% 完美命中
- **早期数据（ESMO 2025 LBA84, Zhou A et al. *Ann Oncol*）**：
 - PDAC 队列 66 例：ORR **40.7%**，DCR **96.7%**，mPFS **5.52 月**
 - ☒ **Smad4 亚组 ORR 83.3%**（爸爸 Smad4 缺失完美命中，但 n 小需谨慎）
 - 91.5% 患者肿瘤缩小
 - Grade ≥3 AE 31.8%，治疗相关死亡 0
- **给药**：口服 QD 600 mg（对胃衰竭患者是劣势，但 NJ 管给药可解决）
- **2025-07 获 FDA Fast Track**
- **中国临床试验**：

试验号	期	状态	PI
NCT06500676	Ph1/2	招募中	陆舜（上海胸科）+ 周爱萍（中国医学科学院肿瘤医院内科主任，田爱茹上级） ；8610-87788495, zhouap1825@126.com
NCT07262567	Ph3	RECRUITING (2025-12 启动)	沈琳（北大肿瘤） ；二线 mPDAC vs 化疗对照（AG / nal-IRI+5FU/LV / S-1）；Ph3 化疗对照组通常允许 ECOG 2（需向劲方医学部索取方案原文）

- **爸爸长期用药相互作用注意**：
 - ⚠ 耐信 PPI 与 GFH375 弱碱性 TKI 相互作用 → 生物利用度可能降 40-80%，入组需换 H2RA 法莫替丁
 - CYP3A4 底物评估（阿托伐他汀、氨氯地平、多巴丝肼）
 - 西洛他唑抗血小板：治疗期常规停

☒ 新增 2: nal-IRI + 5-FU/LV（脂质体伊立替康）—— 循证首选兜底

- NAPOLI-1（Wang-Gillam *Lancet* 2016, PMID: 26615328）：mOS 6.1 vs 4.2 月（HR 0.67, p=0.012）
- NCCN v2.2025 PDAC 二线首选（Category 1）
- 中国 2022-04 NMPA 已上市（Onivyde 原研 Ipsen/Servier；国产多恩益/济立安/越优力）
- **KPS ≥70（≈ ECOG 2）可用** → 对爸爸门槛更友好
- 静脉给药绕过胃衰竭 ☒

- 主要不良反应：迟发性腹泻（第 3-10 天）+ 骨髓抑制
- UGT1A1*28 纯合子减量至 50 mg/m²（爸爸基因型待查）

完整二线决策梯度

级别	方案	ECOG	mOS	适用性
1 最积极	GFH375 Ph3 NCT07262567	0-2?	未知（早期数据惊艳）	☒ 首选咨询（田爱茹→周爱萍 / 沈琳）
2 标准二线	nal-IRI + 5-FU/LV	0-2	6.1 m	☒ 循证首选兜底
3 减量	Gemcitabine 单药	0-3	3-5 m	毒性最小
4 口服	S-1 单药	0-2	3-5 m	门诊方便
5 BSC	姑息	3-4	1-3 m	兜底

明确排除

- ☒ mFOLFIRINOX / NALIRIFOX（ECOG 2-3 高毒性死亡）
- ☒ PD-1 / PD-L1 单抗（PD-L1 CPS<1、MSS、TMB 低 = 冷肿瘤无益）
- ☒ CT041 CAR-T（预处理风险 > 获益）
- ☒ Zolbetuximab off-label（PDAC 项目终止）
- ☒ 尼妥珠单抗（KRAS G12D 突变，NOTABLE 亚组无益）
- ☒ 一切"NK 细胞免疫""DC-CIK"保健式细胞治疗（伪循证）

9.D 咨询伪细胞治疗 5 大红旗（家人共用参考）

1. ☒ 承诺"高治愈率""包治""无副作用"
2. ☒ 无 NCT / ChiCTR 试验注册号
3. ☒ 民营诊所"NK 细胞免疫""DC-CIK"保健
4. ☒ 要求自费 30-100 万现金
5. ☒ 未在三级医院实施

中国实体瘤 CAR-T 目前无一款上市，只能通过正规临床试验参与。

十、【v1.2 新增】MDT 讨论建议问题清单（按优先级）

☒☒☒☒ 最紧迫（今明必推）

1. **营养通道重建**：Grade 3 胃衰竭 = ACG 2022 EN/PN 绝对适应证，能否**立即置 NJ 管**？是否联系北医三院姚炜团队？
2. **胃动力药方案**：红霉素 3 mg/kg IV q8h × 3-5 天为首选；多潘立酮需 ECG QTc<450 ms 后 ≤30 mg/d ≤7 天；**确认医嘱未开甲氧氯普胺**

3. **胆道支架 Plan B**: 塑料支架 2026-07-20 内镜下无法更换的具体原因? EUS-HGS 联系令狐恩强(301) / 张澍田(友谊)?
4. **抗生素升级**: 舒普深 20+ 天 → 生物膜性感染 (PCT/IL-6 解偶联), 是否升级美罗培南 / 头孢哌酮舒巴坦 / 加万古或替加环素?
5. **术前 VitK1 10 mg IM/IV** (起效 12-24 h, 纠正 PT-% 74↓)
6. **下肢静脉超声排查 DVT** (D-Dimer 0.957 ↑ ↑ 3.94× 上限 + 卧床 + 中心静脉导管)

☒☒☒ 中优先级 (本周)

7. **PN 达标**: $25-30 \text{ kcal/kg/d} \times 65 \text{ kg} = 1600-1950 \text{ kcal/d}$; 蛋白 $1.2-1.5 \text{ g/kg/d} = 78-98 \text{ g}$; BCAA + ω -3 脂肪乳 + 白蛋白输注 (ALB 33.9↓)
8. **电解质补充**: Na 132↓ 补钠 + K 3.56 预防性补钾 + 鉴别 SIADH
9. **抗凝药物评估**: LMWH 预防剂量 (PLT 177 ☒ 安全; PT-% 74↓ 需权衡)
10. **西洛他唑评估**: PLT 已恢复 + 换支架手术风险 → 是否短期停用
11. **AG 化疗方向决策**: C4 继续 vs 延后 vs 换 nal-IRI vs 入 GFH375 Ph3
12. **临床试验入组路径**: 田爱茹 → 周爱萍教授 (NCT06500676 Ph1/2 PI); 或直接挂沈琳 / 张小田 (北大肿瘤 Ph3 PI)

☒☒ 中期 (1-2 周)

13. **神经内科会诊**: 评估血管性帕金森综合征稳定性, 为胃动力药安全性背书
14. **UGT1A1*28 基因型检测** (如考虑 nal-IRI 二线)
15. **凝血 3-5 天复查**: D-Dimer + PT-% + FDP + 血常规
16. **PCT / IL-6 每 48 h 复查** (观察生物膜性感染趋势)

☒ 长期

17. **心脏基线保存** (NT-proBNP + TnT 已建档, 后续二线化疗安全评估基础)
 18. **多学科随访结构化** (营养科 + 感染科 + 内镜 + 消化 + 肿瘤内科 + 神经内科 + 疼痛/姑息)
-

十一、v1.2 版本变更摘要

章节	v1.1 → v1.2 变更
抬头	版本号 v1.2; 汇报日期改 2026-07-22; 聚焦目的明确化
一	增加住院号 106034 / 床号 05-09; 主要照护家属
二	新增当前活动性问题清单 8 条
3.1	增加桥本氏甲状腺炎; 帕金森 → 血管性帕金森综合征 (VP) 精修, 含胃动力药选择的临床影响
四	时间线增补: 7/9-7/11 连续发烧、7/12 反弹、7/14 蒋斌二线咨询、7/19 三份化验、7/19-7/21 三次呕吐、7/20 北医三院胆道支架不可换 + Grade 3 胃衰竭确诊、7/21 300 ml 水呕吐
四	修正 v1.1 错误: 7/2 二线咨询医院从"北京高博"改为"北京大学肿瘤医院"
7.3	骨髓抑制轨迹增加 7/19 全线反弹行 (PLT 111 → 177 +59% 是黄金手术窗信号)
7.4	感染 PCT / IL-6 增加 7/19 (PCT 0.700 vs 7/3 +419%; PCT/IL-6 解偶联证明生物膜性感染)
7.5	凝血四联增加 Phase 4: 7/19 D-Dimer 再度攀升 +105% + FDP 解偶联
7.6-7.9 新增	VitK 依赖凝血合成障碍 / 心功能安全底座 (NT-proBNP + TnT) / 恶病质双-三重证据链 (CK + Mb + Cr) / 电解质紊乱 (Na + K)
八	医生一览增补张铃福、姚炜 (3 次)、田爱茹、周军、蒋斌、霍菲菲; 表格补全 (v1.1 表格未闭合)
九 新增	当前核心临床决策问题 (Grade 3 胃衰竭 EN/PN / EUS-HGS Plan B / 二线方案)
九.C	二线方案大幅更新: CT041 由主线降级为硬性排除; Zolbetuximab PDAC 项目终止; GFH375 Ph1/2 NCT06500676 + Ph3 NCT07262567 首选 (分子命中 + Smad4 亚组 ORR 83.3% + 田爱茹→周爱萍团队路径); nal-IRI 循证兜底; 完整决策梯度 5 级
十 新增	MDT 讨论建议问题清单 (18 条按优先级排序)

汇报日期: 2026-07-22 版本: v1.2 下次预计更新: MDT 会诊后 / 关键化验反弹后 / NJ 管置入后